

Adherencja *lekowa*

50% osób z BD odstawia stabilizator w pierwszych 12 miesiącach. Regularne przyjmowanie leku jest podstawą profilaktyki nawrotów — co zwiększa, co utrudnia.

CZAS: 20 min — psychoedukacja **CHARAKTER:** profilaktyka nawrotów

ŹRÓDŁO: Colom (2014); Velligan i wsp. (2009)

JAK UŻYWAĆ

Sprawdź, które z 5 najczęstszych powodów odstawiania dotyczą Ciebie. Wybierz **system przypominający** (pudełko, alarm, aplikacja), **stałe miejsce** i **porę** przyjmowania. Powiedz **1 zaufanej osobie** o leku. Rozmawiaj z psychiatrą co 3 miesiące o skutkach ubocznych — nie znoś ich milcząco.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Colom (2014, „*Psychoeducation for Bipolar Disorder*”): adherencja lekowa nie jest pytaniem moralnym — jest **umiejętnością**, której można się nauczyć. Velligan i wsp. (2009): **50%** pacjentów odstawia stabilizator w 12 mies., skutki: 3–5× wyższe ryzyko nawrotu, hospitalizacji, prób samobójczych. Psychoedukacja Coloma (21-sesyjna grupa) **podwaja** adherencję w 5-letnim follow-upie.

01 ? Pięć powodów odstawiania — i odpowiedzi

1 · „SKUTKI UBOCZNE WYKAŃCZAJĄ”

Realne. Porozmawiaj z psychiatrą — można zmienić dawkę, czas (rano/wieczór), preparat. *Nie odstawiaj samodzielnie.*

2 · „CZUJĘ SIĘ DOBRZE, NIE POTRZEBUJĘ”

Lek *powoduje*, że czujesz się dobrze. Odstawienie zwykle prowadzi do nawrotu w 3–6 miesięcy.

3 · „TĘSKNIĘ ZA ENERGIAŁ HIPOMANII”

Realne — bywa „*najlepszym uczuciem życia*”. Ale hipomania prawie zawsze prowadzi do manii lub depresji.

4 · „LEK = JESTEM CHORY/-A”

Lek to etykieta. To narzędzie. Bez insuliny diabetek nie jest „*mniej chory*” — tylko bardziej zagrożony.

5 · „ZAPOMINAM / BRAK CZASU”

Rozwiązania: pudełko dzielone na dni, alarmy, łączenie z istniejącym rytuałem (mycie zębów). Aplikacje: Medisafe, MyTherapy.

⚙️ KONSEKWENCJA

Adherencja nie wymaga heroicznej woli — wymaga *systemu*. Im prostszy, tym lepszy.

02 ✓ Strategie wspierające adherencję

1. Stałe miejsce — widoczne, ale bezpieczne · **2. Stała pora** — rano przy kawie / wieczorem przy myciu zębów · **3. Pudełko tygodniowe** — przegródki pn-nd · **4. Alarm** — w telefonie lub aplikacja · **5. Zapas** — zawsze 5+ dni leku w domu · **6. Plan na podróż** — lek w bagażu podręcznym · **7. Zaufana osoba** — 1 osoba wie o leku · **8. Wizyty u psychiatry** — co 3 mies. o skutkach ubocznych.

03 Mój plan adherencji

Wypełnij szczegółowo. Im prostszy plan, tym lepiej działa.

LEK

nazwa

DAWKA

PORA PRZYJMOWANIA

np. 7:00 i 22:00

STAŁE MIEJSCE LEKU

gdzie trzymam

RYTUAŁ, DO KTÓREGO DOŁĄCZAM

np. „mycie zębów”

SYSTEM PRZYPOMINAJĄCY

pudełko / alarm / aplikacja

ZAUFANA OSOBA + WIZYTA U PSYCHIATRY

imię/kontakt oraz data

04 Dziennik pierwszych 4 tygodni

DZIEŃ	LEK WZIĘTY RANO? ✓ / X	LEK WZIĘTY WIECZÓR? ✓ / X	SKUTKI UBOCZNE (KRÓTKO)	NASTRÓJ OGÓLNY 0–10

Klucz: Colom (2014): „adherencja lekowa w BD nie jest tematem moralności, lecz **umiejętnością**. Wymaga zrozumienia, narzędzi i wsparcia. Lek nie zabiera ci wolności — chroni ją”.